

17. Le centrage de l'incidence profil trans-thoracique de l'épaule :

a.	RD incliné de 15° vers le bas visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.	☐
b.	RD incliné de 15° vers le haut visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.	☐
c.	RD incliné de 25° vers le bas visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.	☐
d.	RD horizontal visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.	☐

18. Pour un patient qui présente un traumatisme au niveau de l'épaule, la ou les incidences de choix à réaliser :

a.	Face de l'épaule en rotation externe	☐
b.	Face de l'épaule en rotation neutre	☐
c.	Bernageau	☐
d.	Profil trans-thoracique	☐

19. Le centrage de l'incidence clavicule de face en postéro-antérieur :

a.	RDV centré sur l'angle sup-externe de l'omoplate	☐
b.	RDV centré sur l'angle sup-interne de l'omoplate	☐
c.	RD incliné de 20° centré sur l'angle sup-externe de l'omoplate	☐
d.	RD incliné de 20° centré sur l'angle sup-externe de l'omoplate	☐

20. Le centrage du rachis cervical de profil peut être:

a.	RDH à mi-hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule sur la ligne des épineuses	☐
b.	RDH à mi-hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule à 2travers de doigts en avant de la ligne des épineuses	☐
c.	RDV à mi hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule sur la ligne des épineuses	☐
d.	RDV à mi-hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule à 2travers de doigts en avant de la ligne des épineuses	☐

21. La ou les indications du rachis cervical de face debout :

a.	Recherche de traumatisme	☐
b.	Douleurs cervicales	☐
c.	Hauteur des disques intervertébraux	☐
d.	Etude statique et appréciation morphologique	☐

22. Parmi les critères de réussite du rachis cervical de face :

a.	Position médiane de la ligne des épineuses	☐
b.	Dégagement de tous les interlignes intervertébraux et articulaires postérieurs	☐
c.	Position symétrique du maxillaire inférieur	☐
d.	Bonne visibilité des disques intervertébraux de C3C4 à C7D1	☐

23. La ou les incidences qui permettent de voir le rachis cervical entier de face en effaçant la mandibule :

a.	Incidence cervical de face debout	☐
b.	Incidence cervical de face en demandant au patient de fermer et d'ouvrir sa bouche	☐
c.	Incidence de Pélissier	☐
d.	Incidence de Dorland	☐

24. Parmi les incidences radiologiques suivantes, lesquelles faut-il réaliser chez un sujet présentant une névralgie cervico-brachiale (NCB) :

a.	Incidence de face du rachis cervical	☐
b.	Incidence de profil du rachis cervical	☐
c.	Incidence de profil de la C.C.O	☐
d.	Incidences obliques du R.C	☐

25. La position du patient dans l'incidence du rachis dorsal en oblique antéropostérieur :

a.	Patient debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen	☐
b.	Patient debout, le côté opposé à celui à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen	☐
c.	Patient debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen	☐
d.	Patient debout, le côté opposé à celui à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen	☐

26. L'incidence du sacrum de face, le patient est :

a.	Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD ascendant de 15°	☐
b.	Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD descendant de 15°	☐
c.	Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD ascendant de 20°	☐
d.	Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD descendant de 20°	☐

27. Le RD de l'incidence du Coccyx de face en postéro/anérieur

a.	Descendant de 10°	☐
b.	Ascendant de 10°	☐
c.	Descendant de 20°	☐
d.	Ascendant de 20°	☐

28. La ou les incidences de choix à réaliser pour une patiente qui présente une lésion osseuse des côtes avec une éventuelle extension vers la plèvre :

a.	Grille costale de face debout	☐
b.	Grille costale de face en décubitus dorsale	☐
c.	Grille costal de profil en décubitus dorsal	☐
d.	Grille costale en oblique debout	☐

29. Pour réaliser l'incidence de sternum de face:

a.	Malade en O.A.D de 20° à 30° en station verticale R.D.H	☐
b.	Malade en O.P.D de 20° à 30° en station verticale R.D.H	☐
c.	Malade en O.P.G de 20° à 30° en station verticale R.D.H	☐
d.	Malade en DV, le R.D oblique de 20° à 30°	☐

30. Pour définir une incidence qui permet d'explorer radiologiquement le crâne, il suffit d'indiquer :

a.	Les résultats normaux	☐
b.	Les variantes de cette incidence	☐
c.	L'angle du rayon directeur	☐
d.	Un point de centrage bien déterminé	☐

31. Le centrage de l'incidence du crâne d'ensemble de profil :

a.	Point situé à 4cm au dessus du tragus	☐
b.	Point situé à mi-distance entre le tragus et l'apophyse orbitaire externe	☐
c.	Le point situé à 2 travers de doigts en avant et au dessus du tragus	☐
d.	Le point situé à 4cm au dessus et à 2cm en avant du tragus	☐

32. La ou les incidences qui permettent d'explorer la base du crâne :

a.	Semi axiale (Worms)	☐
b.	Face haute	☐
c.	Profil	☐
d.	Axiale (Hirtz) et ses variantes (Sub-axiale et hyper-axiale)	☐

33. L'angulation et le centrage de l'incidence Blondeau :

a.	-50° vise le nasion	☐
b.	-50° vise l'acanthion	☐
c.	+50° vise le nasion	☐
d.	+50° vise l'acanthion	☐

34. La ou les incidences de choix à réaliser pour un patient qui se présente au service de RX pour une sinusite de contrôle sont :

a.	Profil	☐
b.	Blondeau	☐
c.	Schuller II	☐
d.	Plancher dans les orbites	☐

35. Le centrage de l'incidence qui permet de dégager l'articulation temporo-maxillaire (Schuller I)

a.	6,5 cm au dessus du conduit auditif externe	☐
b.	4,5cm au dessus du conduit auditif externe	☐
c.	2cm au dessus du conduit auditif externe	☐
d.	Rase le bord supérieur du conduit auditif externe	☐

36. Les images radiologiques au niveau du grêle en cas de niveaux hydro-aériques sont :

a.	Plus larges que hautes	☐
b.	Périphériques	☐
c.	Plus hautes que larges	☐
d.	Nombreuses et centrales	☐

37. La ou les techniques qui permettent de visualiser un pneumopéritoine :

a.	ASP en décubitus latéral avec rayon horizontal	☐
b.	ASP de profil avec rayon vertical	☐
c.	ASP en décubitus dorsal	☐
d.	ASP de face debout	☐

38. Dans l'incidence poumons de face de décubitus dorsal, on centre :

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| a. | Sur la fourchette sternale | ☐ |
| b. | A l'appendice xiphoïde | ☐ |
| c. | A 8 cm au dessous de la fourchette sternale | ☐ |
| d. | A 2 cm au dessus de la fourchette sternale | ☐ |

39. Dans l'incidence de poumons de face en Trendelenburg ; l'inclinaison de la table est de :

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a. | 30° de sorte que la tête soit plus basse que les pieds | ☐ |
| b. | 30° de sorte que les pieds soient plus bas que la tête | ☐ |
| c. | 60° de sorte que la tête soit plus basse que les pieds | ☐ |
| d. | 60° de sorte que les pieds soient plus bas que la tête | ☐ |

40. En cas d'œdème pulmonaire (OAP) il faut :

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a. | O ₂ | ☐ |
| b. | Faire la position demi-assise | ☐ |
| c. | Injecter par voie intraveineuse le lasilix | ☐ |
| d. | Injecter l'adrénaline | ☐ |

41. Les structures suivantes font partie du réseau hospitalier :

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a. | Les centres d'oncologie | ☐ |
| b. | Le centre de croissant rouge marocain | ☐ |
| c. | les centres de santé | ☐ |
| d. | La Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires (DHSA) | ☐ |

42. Une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière est appelée :

- | | | |
|----|----------------|--------------------------|
| a. | Épidémie | ☐ |
| b. | Pandémie | ☐ |
| c. | Endémie | ☐ |
| d. | Cas sporadique | ☐ |

43. L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| a. | Le réseau des établissements des soins de santé primaires | ☐ |
| b. | Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (RISUM) | ☐ |
| c. | Le réseau des établissements médico-sociaux publics (REMSP) | ☐ |
| d. | Les structures spécialisées d'appui | ☐ |

44. Le Centre Hospitalier Ibn Sina est un :

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a. | Etablissement public | ☐ |
| b. | Un service d'Etat géré de manière autonome | ☐ |
| c. | Un service d'Etat géré en régie | ☐ |

6. Parmi ces incidences, la ou les incidences fondamentales dans l'exploration de l'articulation coxo-fémorale :

- a. Profil de Lequesne et de « Desèze »
- b. L'incidence de face
- c. Profil d'Arcelin (externe)
- d. Profil urétral (externe)

7. Les incidences axiales du genou ou défilés rotaliens : 30°, 60° et 90° :

- a. Le patient en décubitus dorsal
- b. La cassette est maintenue sur la face antérieure des fémurs par le patient
- c. Angle mesuré est le prolongement de l'axe du fémur avec l'axe de la jambe
- d. Angle mesuré est l'axe du fémur avec l'axe de la jambe

8. Un patient qui ne peut pas faire l'extension complète de la jambe sur la cuisse, se présente au service RX. La ou les incidences de choix à réaliser sont :

- a. Face en postéro-antérieur
- b. Profil avec RDH
- c. Profil avec RDV
- d. Face en antéro-postérieur

9. Vous recevez un enfant âgé de 3 ans accompagné par sa maman pour une fracture ouverte de la jambe. Votre conduite par rapport à la maman en cas de refus de l'enfant de rester seul :

- a. Forcer l'enfant de rester seul
- b. Autoriser la maman de rester près de son enfant en portant une blouse plombée
- c. Autoriser la maman de rester près de son enfant sans blouse plombée
- d. Demander de l'aide auprès des accompagnants d'autres malades

10. Quelles sont les incidences nécessaires à réaliser pour cet enfant :

- a. Jambe de face
- b. Poumon en DD
- c. Jambe de profil avec RDH et patient en décubitus dorsale
- d. Jambe de profil avec RDV et patient en décubitus latérale

SECTION : TECHNICIEN DE RADIOLOGIE



Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1- Lorsqu'un patient se présente pour la première fois au niveau d'un service de RX, on commence par :

a.	Les incidences fondamentales	☐
b.	Les incidences complémentaires	☐
c.	Les variantes	☐
d.	Les incidences de nécessité	☐

2- L'incidence bassin de face :

a.	On centre à 2travers de doigts au dessus de la symphyse pubienne	☐
b.	On centre à 1travers de doigts au dessus de la symphyse pubienne	☐
c.	Les ailes iliaques sont dégagées strictement de face	☐
d.	Les ailes iliaques sont dégagées en oblique	☐

3- Pour un patient présentant une fracture du col fémoral, la ou les examens radiologiques de choix à réaliser :

a.	Face de la hanche sans rotation interne et l'incidence urétrale	☐
b.	Face de la hanche avec rotation interne et l'incidence urétrale	☐
c.	Face de la hanche sans rotation interne et l'incidence d'Arcelin	☐
e.	Face de la hanche sans rotation et l'incidence urétrale	☐

4- Parmi les critères de réussite du $\frac{3}{4}$ alaire du bassin :

a.	Les limites du trou obturateur sont superposées	☐
b.	Cotyle vue de face	☐
c.	Cotyle de profil	☐
d.	Le trou obturateur est ouvert.	☐

5- Quelle est la ou les incidences du profil de la hanche qui permettent d'utiliser le Potter ou le portique :

a.	Incidence d'Arcelin	☐
b.	Incidence urétrale	☐
c.	Incidence de Lequesne	☐
d.	Incidence de salpêtrière Face en antéropostérieur	☐

11. L'incidence verticale du calcaneum, retro-tibiale descendante :

a.	Est réalisée patient debout
b.	On centre sur la face interne du pied en son milieu
c.	Peut être réalisée de manière symétrique
d.	Permet d'explorer la partie postérieure du calcaneum

12. Centrage de l'incidence Schreck II (scaphoïde de profil) :

a.	RD incliné de 10° vers la tête centré sur l'interligne radio-carpienne
b.	RDV centré sur l'interligne radio-carpienne
c.	RDV centré à 1 cm au-dessus de l'interligne radio-carpienne.
d.	RDV centré à 1 cm au-dessous de l'interligne radio-carpienne

13. L'incidence oblique interne de la main :

a.	Main en appui cubital, le plan de la paume fait un angle de 45° avec la verticale
b.	On centre sur la tête du 1er ou du 2eme metacarpien
c.	On centre sur la tête du 4eme ou 5eme metacarpien
d.	Sur le cliché on voit les metacarpiens superposés

14. L'incidence coude de profil :

a.	Main en pronation, l'avant-bras fléchi à 135° (90° pour Clark)
b.	Main en demi-pronation, l'avant-bras fléchi à 135° (90° pour Clark)
c.	RD centré verticalement sur l'interligne à 1 cm environ au dessous de l'épicondyle
d.	RD centré verticalement sur l'interligne à 1 cm environ au dessus de l'épicondyle

15. Le centrage de l'incidence de l'apophyse coronoïde :

a.	Au milieu de l'interligne radio-humérale
b.	Au milieu de l'interligne radio-cubitale
c.	Au milieu de l'interligne cubito-humérale
d.	Toutes les réponses sont justes

16. Pour étudier la palette humérale de profil, il faut :

a.	L'axe épicondyle-épitrochlé soit parallèle au film
b.	Main en supination
c.	L'axe épicondyle-épitrochlé soit perpendiculaire au film
d.	Main en pronation